



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE 3294-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0216-2026/CC1

DENUNCIANTE : DANIEL VILLAFUERTE PUYEN (SEÑOR VILLAFUERTE)
DENUNCIADOS : SERVICIOS, COBRANZAS E INVERSIONES S.A.C. (EMPRESA DE COBRANZAS E INVERSIONES)
SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (BANCO)
PULSO CORPORACIÓN MÉDICA S.A.C. (CLÍNICA PULSO)
SALUS LABORIS S.A.C. (CLÍNICA SALUS)
DOCTOR + S.A.C. (CLÍNICA SANNA DIVISIÓN AMBULATORIA)
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA
DECLINACIÓN DE COMPETENCIA
RELACIÓN DE CONSUMO
ACTIVIDAD : ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA

Lima, 23 de enero de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 12 de diciembre de 2025 complementado con el escrito del 20 de enero de 2026, el señor Villafuerte denunció a la Empresa de Cobranzas e Inversiones, al Banco, a la Clínica Pulso, Clínica Salus, y a la Clínica Sanna División Ambulatoria, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor¹ (en adelante, el Código), señalando lo siguiente:
 - (i) El 4 de octubre del 2004, empezó a laborar para la Empresa de Cobranzas e Inversiones, que pertenece al grupo del Banco, desempeñándose como gestor de cartera selectiva.
 - (ii) El 1 de abril del 2005, fue incorporado en planilla por la Empresa de Cobranzas e Inversiones, manteniendo una relación laboral continua y sujeta a la estructura operativa vinculada al Banco.
 - (iii) El 24 de enero del 2024, sufrió un infarto cerebral y posteriormente fue diagnosticado con oligodendroglioma grado II, disfasia acentuada y compromiso neurológico permanente.
 - (iv) El 12 de diciembre del 2024, se emitió un certificado de salud en el que se consignó que su estado de salud era favorable y se recomendó la posibilidad de reubicación laboral a partir del 25 de diciembre del 2024 en un área administrativa que no demandara desplazamiento por terreno irregular, sobrecargas de peso ni comunicación verbal fluida.

¹ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano y vigente desde el 2 de octubre del 2010.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE 3294-2025/CC1

- (v) El 18 de diciembre del 2024, remitió el certificado de salud a la Empresa de Cobranzas e Inversiones para su conocimiento y para la adopción de las medidas correspondientes en relación con su situación laboral.
 - (vi) Desde diciembre del 2024 hasta marzo del 2025, fue sometido a múltiples evaluaciones médicas ocupacionales en el marco de su vínculo laboral, las cuales fueron gestionadas por su empleador en coordinación con entidades médicas contratadas, siendo realizadas por la Clínica Pulso, Clínica Salus y la Clínica Sanna División Ambulatoria.
 - (vii) Durante el proceso de evaluaciones médicas ocupacionales, la Clínica Pulso, la Clínica Salus y la Clínica Sanna División Ambulatoria no entregaron la historia clínica completa, emitieron conclusiones sin correlación clínica suficiente, corrigieron reportes previamente emitidos sin fundamentación y no activaron protocolos de riesgo pese a la existencia de hallazgos clínicos relevantes.
 - (viii) En el mismo periodo, se produjeron descoordinaciones la Empresa de Cobranzas e Inversiones y el Banco, lo que impidió el acceso a información vinculada a su situación médica.
 - (ix) Interpuso una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud (en adelante, Susalud) debido a la gravedad del caso; sin embargo, ello no genera una duplicidad, en tanto ante Indecopi denuncia infracciones al Código, vinculadas a la idoneidad de un trato justo e informado.
2. El señor Villafuerte solicitó, en calidad de medida correctiva, que los proveedores denunciados cumplan con: (i) realizar la entrega completa de información médica; (ii) realizar la subsanación de reportes clínicos; (iii) realizar la emisión de reportes claros y trazables; e, (iv) implementar medidas correctivas para evitar que los hechos denunciados se repitan.

ANÁLISIS

Sobre la improcedencia de la denuncia interpuesta por el señor Villafuerte contra la Clínica Pulso, Clínica Salus, y Clínica Sanna División Ambulatoria

3. El artículo 105° del Código establece que el Indecopi es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas, conforme a la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo 1033. Asimismo, en la referida norma se señala que dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.²

²

LEY 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente capítulo, conforme al Decreto legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del

2

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



4. Dicho criterio fue recogido previamente en el precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal de Defensa de la Competencia mediante Resolución 0277-1999/TDC-INDECOPÍ³, que señaló lo siguiente:

“Por excepción establecida en norma expresa de rango legal, únicamente pueden entenderse aquellas disposiciones contenidas en las leyes, u otras normas de igual jerarquía, que señalen que una entidad administrativa, distinta a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, será competente para sancionar presuntas infracciones (a la Ley de Protección al Consumidor) que puedan cometerse en las relaciones de consumo que se presenten en un sector específico”.

5. Al respecto, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, la Comisión) debe verificar si el Indecopi es el órgano competente para pronunciarse sobre el hecho cuestionado por el señor Villafuerte en su denuncia.

(i) De la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud

6. El Decreto Legislativo 1158, cuerpo normativo orientado al fortalecimiento de Susalud, tiene como objetivo⁴ promover, proteger y defender los derechos de quienes accedan a los servicios de salud, garantizando que estos sean de calidad, estableciendo bajo su ámbito de competencia a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).⁵
7. Los artículos 6 y 7 del referido cuerpo normativo precisan que las IAFAS comprenden, entre otras entidades, a las compañías aseguradoras, las Entidades Prestadoras de

Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.
(...)

³ Ver Resolución 277-1999/TDC-INDECOPÍ del 18 de agosto de 1999, seguido por Shirley Sánchez Cama contra José Cantuarias Pacheco y Corporación José R. Lindley S.A.

⁴ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO 1158 y publicado 6 de diciembre de 2013**

Artículo 1.- Objeto de la norma

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto disponer las medidas destinadas al fortalecimiento de las funciones que actualmente desarrolla la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, con la finalidad de promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien la financie.

⁵ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO 1158 y publicado 6 de diciembre de 2013**

Artículo 5.- Ámbito de competencia

La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad desconcentrada y sus competencias son de alcance nacional. Se encuentran bajo el ámbito de competencia de la Superintendencia todas las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS). Asimismo, se encuentran bajo el ámbito de competencia de la Superintendencia las Unidades de Gestión de IPRESS, definidas como aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, diferentes de las IPRESS, encargadas de la administración y gestión de los recursos destinados al funcionamiento idóneo de las IPRESS.
(...)



Servicios de Salud (EPS) y Asociaciones de Fondos Regionales y Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT), mientras que las IPRESS se encuentran comprendidas por establecimientos de salud, servicios de apoyo médico y servicios complementarios o auxiliares de atención médica.⁶

8. De la lectura conjunta de los referidos dispositivos legales, se desprende que Susalud es una entidad que tiene como finalidad la protección de los intereses de las personas que accedan a servicios de salud, lográndose dicho objetivo a través de la supervisión de las IAFAS e IPRESS.
9. A fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones y objetivos, Susalud cuenta con potestad sancionadora para reprimir aquellas conductas que afecten: (i) el derecho a la vida, salud e información de los usuarios de servicios de salud y la cobertura para su aseguramiento; y, (ii) los estándares de acceso, calidad, oportunidad y disponibilidad con los que dichas prestaciones serán otorgadas.⁷

⁶ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD**, aprobada por **DECRETO LEGISLATIVO 1158** y publicado 6 de diciembre de 2013

Artículo 6.- De las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS

Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) son aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por crearse, que reciban, capten y/o gestionen fondos para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad. El registro en la Superintendencia Nacional de Salud es requisito indispensable para la oferta de las coberturas antes señaladas.

Son IAFAS las siguientes:

1. Seguro Integral de Salud.
2. Seguro Social de Salud (EsSalud), excluyendo la cobertura de prestaciones económicas y sociales.
3. Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).
4. Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
5. Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
6. Empresas de Seguros contempladas en los numerales 1, 2 y 3 del inciso d) del artículo 16° de la Ley 26702, que oferten cobertura de riesgos de salud de modo exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas.
7. Asociaciones de Fondos Regionales y Provinciales Contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT).
8. Entidades de Salud que ofrecen servicios de salud prepagadas.
9. Autoseguros y fondos de salud, que gestionen fondos para la cobertura de salud de modo exclusivo o en adición a otro tipo de coberturas.
10. Otras modalidades de aseguramiento público, privado o mixto distintas a las señaladas anteriormente.

Artículo 7.-De las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de la salud. En adición al cumplimiento de las normas de carácter general del Ministerio de Salud, para brindar servicios de salud deberán encontrarse registradas en la Superintendencia Nacional de Salud.

⁷ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD**, aprobada por **DECRETO LEGISLATIVO 1158** y publicado 6 de diciembre de 2013

Artículo 10.- Potestad sancionadora de la Superintendencia

Para el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 8 y 9 del presente Decreto Legislativo, la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con potestad sancionadora sobre toda acción u omisión que afecte: i) el derecho a la vida, la salud, la información de las personas usuarias de los servicios de salud y la cobertura para su aseguramiento, y; ii) los estándares de acceso, calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad con que dichas prestaciones sean otorgadas. (...)



10. Dichas conductas, conforme al artículo 11 del citado dispositivo legal, acarrearán la imposición de sanciones que abarcan desde una amonestación escrita hasta la revocación de la autorización de funcionamiento para las IAFAS e IPRESS⁸.
11. Asimismo, conforme al Anexo I-C del Reglamento de Infracciones y Sanciones de Susalud, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2014-SA, dicha entidad se encuentra facultada para sancionar, entre otras conductas, el hecho consistente en modificar o contravenir el clausulado mínimo de los contratos o convenios suscritos con una IAFAS⁹.
12. Adicionalmente a su potestad sancionadora, Susalud se encuentra facultada a ordenar medidas correctivas, a fin de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente.¹⁰
13. En efecto, dichas medidas correctivas consistirán, por ejemplo, en la devolución de los cobros indebidos realizados por quienes incurrieron en la conducta infractora, la atención a la solicitud de información requerida por el asegurado, la declaración de inexigibilidad de las cláusulas de sus contratos que resulten abusivas y/o la publicación de avisos rectificatorios o informativos, así como las medidas correctivas que dispone el Código y que resultan aplicables a su ámbito de competencia¹¹.

⁸ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD**, aprobada por **DECRETO LEGISLATIVO 1158** y publicado 6 de diciembre de 2013

Artículo 11.- Tipos de Sanciones

La Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, puede imponer a las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS, vinculadas al Sistema Nacional de Salud, los siguientes tipos de sanción:

- a. Amonestación escrita;
 - b. Multa hasta un monto máximo de quinientas (500) UIT;
 - c. Suspensión de la Autorización de Funcionamiento para IAFAS, hasta por un plazo máximo de seis (6) meses, cuyo efecto consiste en el impedimento para realizar nuevas afiliaciones;
 - d. Restricción de uno o más servicios de IPRESS, hasta por un plazo máximo de seis (6) meses;
 - e. Cierre temporal para IPRESS, hasta por un plazo máximo de seis (6) meses;
 - f. Revocación de la Autorización de Funcionamiento para IAFAS;
 - g. Cierre definitivo para IPRESS.
- (...)

⁹ **ANEXO III - INFRACCIONES APLICABLES A LAS IPRESS**

ANEXO III – A INFRACCIONES DE CARACTER GENERAL
INFRACCIONES LEVES

(...)

26. Modificar o contravenir el clausulado mínimo de los contratos o convenios suscritos con una IAFAS.

(...).

¹⁰ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD**, aprobada por **DECRETO LEGISLATIVO 1158** y publicado 6 de diciembre de 2013

Artículo 10.- Potestad sancionadora de la Superintendencia

(...)

Sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su competencia imponga la Superintendencia Nacional de Salud, podrá ordenar la implementación de una o más medidas correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente.

(...)

¹¹ **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD**, aprobada por **DECRETO LEGISLATIVO 1158** y publicado 6 de diciembre de 2013

Artículo 14.- Medidas correctivas



14. Además, Susalud tiene la potestad de aplicar multas coercitivas en el supuesto que los infractores sancionados sean renuentes al cumplimiento de la sanción impuesta, las medidas correctivas ordenadas y/o en caso incurran nuevamente en la conducta infractora¹².
15. Por otro lado, el 13 de agosto de 2015, se publicó el Reglamento del Procedimiento de Transferencia de Funciones del Indecopi a Susalud, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2015-SA (en adelante, Reglamento de Transferencia de Funciones), el cual establece que esta última entidad es la autoridad competente para promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, así como para conocer, con competencia primaria y alcance nacional, las presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con la IPRESS y/o IAFAS.¹³

Las medidas correctivas se dictan conjuntamente con la resolución que impone la sanción, y tienen por finalidad corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, la Superintendencia podrá ordenar la implementación de una o más de las siguientes medidas correctivas:

1. Devolver los cobros indebidos o en exceso, según la cobertura de los planes de salud correspondientes.
 2. Cumplir con atender la solicitud de información requerida por el asegurado, siempre que dicho requerimiento guarde relación con su cobertura de salud y/o afecte el ejercicio de sus derechos;
 3. Declarar inexigibles las cláusulas de sus contratos o convenios que han sido identificadas como abusivas;
 4. Publicar avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la Superintendencia Nacional de Salud tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto materia de sanción hubiere ocasionado;
 5. Someter a la IAFAS al Régimen de Vigilancia, entendido como el proceso de supervisión continua a la IAFAS previa presentación de su Plan de Recuperación, el cual será aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud.
- (..)

- ¹² **DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE MEDIDAS DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO 1158 y publicado 6 de diciembre de 2013**

Artículo 15.- Multas coercitivas

Si los infractores sancionados son renuentes al cumplimiento de la sanción, o de las medidas correctivas ordenadas, dentro del plazo otorgado, se les impondrá una multa coercitiva no menor de tres (3) UIT. Si el administrado persistiese en el incumplimiento, se podrá imponer una nueva multa coercitiva, la cual podrá ser reiterada en forma trimestral, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta, hasta el límite de cincuenta (50) UIT. La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notificada.

- ¹³ **REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUSALUD EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1158, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 026-2015-SA y publicado el 13 de agosto de 2015**

Artículo 5.- Competencias Generales de la Superintendencia Nacional de Salud

- 5.1. SUSALUD es la autoridad competente para promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien las financie, así como los que correspondan en su relación de consumo con las IAFAS e IPRESS, incluyendo aquellas previas y derivadas de dicha relación; así como para conocer con competencia primaria y alcance nacional, las presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con la IPRESS y/o IAFAS.
- 5.2. SUSALUD es competente también para identificar las cláusulas abusivas en los contratos o convenios que suscriben las IAFAS con los asegurados o entidades que los representen, según las disposiciones aplicables de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, con excepción de las pólizas de seguros de las Empresas de Seguros bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, sin perjuicio de la protección al consumidor o usuario directamente afectado respecto de la aplicación de la referida cláusula en el caso en concreto.
- 5.3. SUSALUD velará por el cumplimiento de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y sus normas complementarias y conexas, en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de



16. Ahora bien, respecto de la competencia de Susalud y del Indecopi, el artículo 9 del citado Reglamento¹⁴ dispone lo siguiente:
- (i) **Susalud** asume competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos a partir de la vigencia de la norma (14 de agosto de 2015), que constituyan presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con las instituciones bajo su ámbito de competencia, así como aquellas previas o derivadas de esta.
 - (ii) **Indecopi** mantiene competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos antes de la vigencia de la norma (hasta el 13 de agosto de 2015), en las materias señaladas en el párrafo precedente, hasta su conclusión en la vía administrativa, arbitral y/o sede judicial.
17. Por su parte, el Reglamento para la Atención de Reclamos y Quejas de los Usuarios de las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2016-SA y publicado el 27 de julio de 2016, establece que Susalud es la autoridad competente para conocer y resolver los procedimientos para la atención de reclamos y quejas de usuarios establecidos por dicha entidad¹⁵.

salud, por la falta de idoneidad de los servicios ofrecidos por las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, ejerciendo su potestad sancionadora en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1158.

¹⁴ **REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUSALUD EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1158, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 026-2015-SA y publicado el 13 de agosto de 2015**

Artículo 9.- Procedimientos asumidos por SUSALUD

SUSALUD asume competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos a partir de la vigencia de la presente norma, que constituyan presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con las instituciones bajo su ámbito de competencia, así como aquellas previas o derivadas de ésta.

INDECOPI mantiene competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos antes de la vigencia de la presente norma, en las materias señaladas en el párrafo precedente, hasta su conclusión en la vía administrativa, arbitral y/o sede judicial.

¹⁵ **REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS DE LOS USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD – IAFAS, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD – IPRESS Y UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD – UGIPRESS, PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS, aprobado por DECRETO SUPREMO 030-2016-SA y publicado el 27 de julio de 2016**

Artículo 1.- Del objeto

1.1. Establecer el procedimiento para la atención de las quejas y reclamos presentados por los usuarios o terceros legitimados ante la insatisfacción respecto de los servicios, prestaciones o coberturas solicitadas a, o recibidas de, las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPRESS, o que dependan de las Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas.

(...).

Artículo 4.- Del ámbito de aplicación

4.1. El presente Reglamento es aplicable a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas o mixtas a nivel nacional; a los usuarios o terceros legitimados en su relación con dichas instituciones, así como a SUSALUD.

(...).

Artículo 6.- De las instancias competentes

(...)



18. A continuación, se determinará la autoridad competente para conocer la denuncia interpuesta por el señor Villafuerte contra la Clínica Pulso, Clínica Salus, y Clínica Sanna División Ambulatoria, de ser el caso, imponer las sanciones correspondientes.

(ii) Aplicación al caso concreto

19. El numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento del Procedimiento de Transferencia de Funciones establece que Susalud es la entidad encargada de velar por el cumplimiento del Código, así como sus normas complementarias y conexas en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud.¹⁶
20. De lo expuesto se desprende que Susalud es la entidad competente para supervisar el cumplimiento de las normas que protegen a los consumidores de la falta de idoneidad respecto de las prestaciones de salud, así como el derecho de los consumidores a acceder a información vinculada a dichas prestaciones.
21. En el presente caso, el señor Villafuerte cuestionó que la Clínica Pulso, Clínica Salus, y Clínica Sanna División Ambulatoria: (i) habrían realizado evaluaciones médicas ocupacionales incompletas y defectuosas, al omitir exámenes obligatorios, resultados contradictorios y modificar conclusiones previamente emitidas sin sustento clínico vinculadas a la condición médica acreditada mediante el certificado de salud del 18 de diciembre del 2024; (ii) no habrían cumplido con entregar reportes completos ni la historia clínica completa; y, (iii) no habrían cumplido con activar protocolos de riesgo pese a hallazgos clínicos relevantes vinculadas a su condición médica acreditada mediante el certificado de salud del 18 de diciembre del 2024.
22. Ahora bien, el denunciante señaló que interpuso una denuncia a Susalud debido a la gravedad del caso; sin embargo, ello no genera una duplicidad, en tanto ante Indecopi denuncia infracciones al Código.

6.2. SUSALUD a través de IPROT o las Intendencias Macro Regionales de SUSALUD en caso de encargo de funciones, son competentes para la recepción, procesamiento, atención y absolución de las consultas, peticiones de intervención y quejas presentadas por los usuarios o terceros legitimados.
(...).

Artículo 12.- De la canalización de reclamos

Los reclamos presentados a las IAFAS, IPRESS O UGIPRESS por cualquier medio deberán ser canalizados por éstas al Libro de Reclamaciones en Salud Virtual o Físico, según corresponda.

16

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUSALUD EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1158, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 026-2015-SA Y PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DE 2015

Artículo 5.- Competencias Generales de la Superintendencia Nacional de Salud

(...)

5.3. SUSALUD velará por el cumplimiento de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y sus normas complementarias y conexas, en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud, por la falta de idoneidad de los servicios ofrecidos por las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, ejerciendo su potestad sancionadora en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1158.



23. Al respecto, conforme a lo desarrollado, el Indecopi no es competente para resolver controversias relacionadas a servicios de salud que generen infracciones al deber de idoneidad, información, entre otros del Código, en la medida que de acuerdo al Reglamento de Transferencia de Funciones es Susalud la encarga de resolver dichas controversias, pudiendo dictar las medidas correctivas correspondientes.
24. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por el señor Villafuerte, Susalud es la encarga de resolver los hechos cuestionados contra Clínica Pulso, Clínica Salus, y Clínica Sanna División Ambulatoria por infracciones al Código.
25. Adicionalmente, este órgano colegiado estima pertinente remitir a Susalud una copia de todo lo actuado en el presente procedimiento, a efectos de que conozca los argumentos y adopte las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia y con el procedimiento que cursa en trámite.

Sobre la improcedencia de la denuncia interpuesta por el señor Villafuerte contra la Empresa de Cobranzas e Inversiones y el Banco

26. Respecto a la protección al consumidor, es preciso advertir que el artículo 65° de la Constitución Política del Perú, consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores. Para tal efecto garantiza una gama de derechos en su favor¹⁷.
27. Así pues, en un mercado en el que concurren proveedores y consumidores cabe siempre la posibilidad de que se produzcan controversias, debido principalmente a la existencia natural de asimetría informativa y a la desigualdad en el poder de negociación contractual. Es por ello que el Estado emite normas de protección al consumidor que dotan de distintos derechos a los consumidores, tales como los de información, protección a las expectativas legítimamente adquiridas —idoneidad—, libre elección, reclamación, trato igualitario, entre otros.
28. En el caso de una denuncia del consumidor, se deberá evaluar si esta cumple con algunos supuestos de procedibilidad establecidos en el Código, por ejemplo, si el denunciante califica como consumidor, si entre el denunciante y el denunciado existió una relación de consumo o si el denunciante pudo verse afectado por una relación de consumo entre terceros, a efectos de que la instancia administrativa emita una resolución sobre el fondo —pronunciamiento de fundabilidad— de la controversia.
29. Al respecto, debemos destacar que el artículo III del Título Preliminar del Código establece que se protege al consumidor que se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta. Asimismo, el numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de dicha norma define quienes pueden ser considerados como consumidores o usuarios y, por ende, quienes

¹⁷**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.



pueden acceder al nivel de protección especial que brinda la normativa de protección al consumidor.

30. De esa forma, los conceptos de consumidor y relación de consumo se encuentran estrechamente vinculados, en una relación de sujeto —situación jurídica/consumidor— a objeto —relación jurídica/relación de consumo—; sin embargo, además de los mencionados conceptos, el Código ha recogido un supuesto adicional de protección —los expuestos o comprendidos por una relación de consumo—. Por tanto, el ámbito de protección del Código se presenta bajo estos dos (2) supuestos:
- (i) cuando un denunciante forma parte de una relación de consumo en virtud de un contrato celebrado con un proveedor; y,
 - (ii) cuando un denunciante alega que merece protección en virtud de haber sido directa o indirectamente expuesto o comprendido en una relación de consumo o haber sufrido los efectos de esta.
31. Así, respecto del primer supuesto, se entenderá a la denominada relación de consumo como aquella configurada por la concurrencia de tres componentes íntimamente ligados y cuyo análisis debe efectuarse de manera integral. Dichos componentes son los siguientes: un consumidor o usuario, un proveedor y un producto o servicio materia de transacción comercial.
32. Ahora bien, respecto del segundo supuesto, se desprende que el Código es aplicable también a casos en los que no se ha configurado propiamente una relación de consumo, pero en los que el denunciante se encontró expuesto, directa o indirectamente, a una etapa previa, a su ejecución o a una etapa posterior a aquella, razón por la cual califica como consumidor.
33. Tal interpretación surge en la medida que el Código no se encuentra restringido exclusivamente a los compradores o contratantes de un producto o servicio —primer supuesto—, pues, conforme a lo expuesto, una persona puede entrar en contacto con dichas prestaciones sin que medie una relación contractual con el proveedor.
34. En ese sentido, la concepción de relación de consumo no se limita a la noción de relación contractual, sino, comprende también aquellos supuestos en los que precisamente los cuestionamientos de los denunciantes obedecen a que, pese a no mantener vínculo alguno con determinado proveedor, éste, a manera de ejemplo, viene remitiéndole requerimientos de pago, atribuyéndole una deuda o reportándolo con calificación negativa ante las Centrales de Riesgos, entre otros.
35. Por la misma línea de razonamiento, la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en la Resolución N° 342-2014/SPC-INDECOPI del 30 de enero de 2014, ha establecido lo siguiente:

“(…)

El ámbito de aplicación del Código no se encuentra restringido exclusivamente a los compradores o contratantes de un producto o servicio, pues como se ha



señalado una persona puede entrar en contacto con dichas prestaciones sin que medie una relación contractual con el proveedor.

Anteriormente, la Sala ha tenido oportunidad de destacar que la aplicación de una noción amplia de consumidor se justifica en la finalidad última de los procedimientos sancionadores en esta materia: cautelar el interés colectivo de los consumidores a través de la evaluación de pretensiones de naturaleza individual. (...)

Así, la relación de consumo no consiste solamente en una relación formal directa, es decir, no es un mero acto traslativo de "cosa - precio" o "servicio - precio", sino que va más allá de la prestación principalmente ofertada incorporando todos aquellos servicios complementarios que posicionan a un proveedor en el mercado distinguiéndolo de sus demás competidores y que definen en última instancia la elección del consumidor a su favor. (...)"

36. Precisamente, la finalidad del Código al incluir en la noción de consumidor a las personas expuestas, directa o indirectamente, a una relación de consumo, a pesar de no ser parte de ella, es la de protegerlas de los efectos de un presunto error o negligencia por parte del proveedor, en virtud de la cual el administrado se encuentra expuesto por una relación de consumo de la cual en ningún momento solicitó ser parte o que al considerar serlo en realidad no pertenecía a ella.
37. En atención a lo expuesto, esta Comisión verificará en el presente caso si la denuncia presentada por el señor Villafuerte contras la Empresa de Cobranzas e Inversiones y el Banco se encuentra en alguno de los supuestos de protección recogidos en el Código, a efectos de verificarse la existencia de una relación de consumo contra dicha entidad.
38. En su denuncia, el señor Villafuerte cuestionó que se produjeron descoordinaciones entre la Empresa de Cobranzas e Inversiones y el Banco, lo que impidió el acceso a información vinculada a su situación médica.
39. De la revisión de lo actuado en el presente procedimiento, se advierte que la Empresa de Cobranzas e Inversiones y el Banco no eran proveedores de un producto o servicio contratado por el señor Villafuerte, sino que actuaron como sus empleadores dentro de una relación laboral. Así pues, según lo narrado por el propio denunciante, este se encontraba laborando para la Empresa de Cobranzas e Inversiones, quien pertenece al grupo del Banco.
40. En ese sentido, si bien existió una relación jurídica entre la Empresa de Cobranzas e Inversiones y el Banco con el señor Villafuerte, lo cierto es que estas fueron de naturaleza laboral, mas no es una relación de consumo en sí misma. En dicha medida, esta Comisión considera que en el presente caso se evidencia la falta de relación de consumo entre estos.
41. Además, corresponde señalar a la parte denunciante que en la medida que se realizó la evaluación de procedencia de la denuncia contra sus empleadores, no corresponde la devolución de la tasa por derecho de trámite pagada, en la medida que dicho supuesto



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE 3294-2025/CC1

solo se encuentra contemplado cuando los cuestionamientos de toda la denuncia se derivan a la entidad competente¹⁸.

42. De lo expuesto, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente, por falta de relación de consumo, la denuncia interpuesta por el señor Villafuerte contra la Empresa de Cobranzas e Inversiones y el Banco, por la presunta infracción a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

RESUELVE

PRIMERO: declarar improcedente la denuncia interpuesta por el señor Daniel Villafuerte Puyen contra Pulso Corporación Médica S.A.C., Salus Laboris S.A.C. y Doctor + S.A.C., por presunta infracción a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que las conductas cuestionadas resulta ser materia de exclusiva competencia de la Superintendencia Nacional de Salud.

SEGUNDO: ordenar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 que remita el original de todo lo actuado en el presente procedimiento a la Superintendencia Nacional de Salud, a efectos de que adopte las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia.

TERCERO: declarar improcedente, por falta de relación de consumo, la denuncia interpuesta por el señor Daniel Villafuerte Puyen contra Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C. y Scotiabank Perú S.A.A., por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: informar al señor Daniel Villafuerte Puyen que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación¹⁹, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente

¹⁸ Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva única que regula los procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección al Consumidor

Artículo 13.- Improcedencia de la denuncia

13.1 En los supuestos en que el órgano resolutorio determine que los hechos materia de denuncia deben ser conocidos por una Junta Arbitral de Consumo o Centro de Arbitraje, o un órgano regulador o supervisor distinto al INDECOPI, la resolución que declara la improcedencia de la denuncia dispone la remisión de los actuados a la entidad que corresponda y la devolución de la tasa pagada por el denunciante.
(...)

¹⁹ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE 3294-2025/CC1

de su notificación²⁰, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida²¹.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

²⁰ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

²¹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.